

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ И ТЕЛА МАТКИ

Шакирова А.Ф., Дзюбина Т.С.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
ГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования. Выявить и установить факторы, определяющие инвалидизацию и реабилитационный потенциал (РП) при раке тела матки и яичников.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 240 медицинских дел освидетельствования 129 больных раком тела матки и 310 медицинских дел освидетельствования 94 больных злокачественными опухолями яичников, пролеченных в ГКП «КООЦ» за пять лет (2001-2005 гг.), 578 историй болезней данных пациенток, специально разработанных кодификаторов, включающих 81 позицию, касающиеся возраста, социального статуса, анамнестических данных, вопросов самого заболевания, его лечения, реабилитации и прогноза. Нами был применен корреляционный анализ всех параметров друг с другом с определением коэффициентов корреляции, направленностью связи и оценкой статистической достоверности, многофакторный дисперсионный анализ в программе ANOVA/MANOVA STATISTICA 5,0.

Результаты. Нами разработан принцип оценки ограничения жизнедеятельности в зависимости от выраженности функциональных нарушений при злокачественных опухолях яичников и тела матки согласно функциональным классам (ФК 1-4). При раке тела матки ФК1-2 имели 409 больных (63,2%), ФК3 – 204 пациенток (31,6%), ФК4 – 34 больных (5,2%). При злокачественных опухолях яичников ФК1-2 имели 60 больных (13,8%), ФК3 – 270 пациенток (62%), ФК4 – 106 больных (24,2%)

У больных раком тела матки высокий реабилитационный потенциал выявлен в 55,7% случаев, в то время, как у больных злокачественными опухолями яичников – всего 0,7% случаев. И наоборот, при раке тела матки процент низкого РП в два раза ниже, чем при опухолях яичников. Таким образом, у больных с опухолями яичников имеет место очень низкий РП.

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену группа инвалидности при раке тела матки достоверно зависела от стадии опухолевого процесса ($r=0,18$; $p<0,001$) и регионарных метастазов ($r=0,25$; $p<0,005$).

На основании проведенного корреляционного анализа по Спирмену реабилитационный потенциал при раке тела матки достоверно зависел от социальной категории ($r=0,15$; $p<0,018$), группы инвалидности ($r=0,13$; $p<0,003$), профессиональной реабилитации ($r=0,31$; $p<0,003$), ограничения трудовой деятельности ($r=0,35$; $p<0,00001$), поддерживающего лечения ($r=0,1$; $p<0,029$).

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену, группа инвалидности при опухолях яичников достоверно зависит от размера опухоли ($r=0,3$; $p<0,02$).

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену, реабилитационный потенциал при новообразованиях яичников достоверно зависит от наличия регионарных метастазов ($r=0,29$; $p<0,012$), хирургического лечения прогрессирования ($r=0,14$; $p<0,036$).

Выводы. При раке тела матки преобладают больные, имеющие ФК1-2 (63,2%), то при злокачественных опухолях яичников – пациентки, имеющие ФК3-4 (86,2%). Вышеизложенный анализ показал, что реабилитационный потенциал при раке тела матки, в основном, зависит от группы инвалидности, социального статуса больной и профессиональной пригодности, а также от терапии при прогрессировании опухолевого процесса. Реабилитационный потенциал при злокачественных опухолях яичников зависит от стадии заболевания, которая определяется наличием и количеством пораженных лимфатических узлов, и выполнения циторедуктивных вмешательств при прогрессировании опухоли и носящих паллиативный характер.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАНЦЕРОГЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ?

Каримов М.А., Доскеева Р.А., Кенжалин Ж.Ш., Койшекенова Г.А.

Изучена заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) населения в Восточно-Казахстанской области (ВКО), по данным областного онкодиспансера за 2004-2008 гг и загрязнение окружающей среды (ЗОС) канцерогенами двух классов: полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и тяжелыми металлами (ТМ). ЗНО изучалась по картам извещения о впервые зарегистрированных ЗНО (ф.090/У); ПАУ определялись по бенз(а)пирену (БП) на аппарате Флюорат-02-2М; ТМ, в частности кадмий (Cd), никель (Ni), свинец (Pb), кобальт (Co) на спектрофотометре С-301. Всего изучено 227765 карт первичных извещений, 82 пробы воды, 74 пробы почвы, 82 пробы растений, употребляемых населением области в пищу (пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха, кукуруза, подсолнух, картофель, свекла, морковь).

Общая ЗНО в ВКО составляла за пятилетие 276,7-264,5‰, тогда как по республике она составляла 192,6-182,6‰. Заболеваемость раком легких была -39,5-38,5‰ (по РК-25,5-22,4‰), раком кожи -42,3-37,3‰ (по РК-18,4-17,5‰), раком МЖ -22,3-28,3‰ (по РК-19,5-20,5‰), раком желудка -22,5-20,4‰ (по РК-18,9-16,8‰). За изученное пятилетие общая ЗНО и заболеваемость раком легких, кожи, желудка снизились, а раком молочной железы - повысилась.

Из всех изученных канцерогенов в зерне и овощах, употребляемых населением, предельно допустимые концентрации

(ПДК) превышали БП, Cd и Pb. Содержание БП в пшенице составляло 9,1-20,9 мкг/кг (9-20 ПДК), Cd - 0,19-0,27 мкг/кг (6-9 ПДК), Pb - 5,9-19,8 мкг/кг (8-9 ПДК). В овсе соответственно БП - 11-20 ПДК, Cd - 8-9 ПДК, Pb - 10-11 ПДК. В ячмене - БП содержалось в пределах 15 ПДК, Cd - 10 ПДК, Pb - 12 ПДК. Рожь «накопила» в себе БП на уровне 10 ПДК, Cd - 3 ПДК, Pb - 13 ПДК. В гречихе - БП - 11 ПДК, Cd - 6 ПДК, а свинца около 14 ПДК. Особо следует подчеркнуть, что в растениях (зерно), содержащих больше жира, БП был значительно больше, так как этот канцероген лучше растворяется в жирах. Так, в кукурузе содержание БП составляло 22 ПДК, а в подсолнухе - 24 ПДК, тогда как содержание Cd было примерно таким же, как и в других видах зерна - 9 ПДК, а свинца выше до 27 ПДК. Содержание БП в овощах также превышало его допустимый фоновый уровень, равный 5,0 мкг/кг и составляло: в картофеле - 5,6-20,3, в моркови - 2,1-15,5 мкг/кг, в свекле - 3,5-14,7 мкг/кг. Cd было в картофеле - 7 ПДК, в моркови - 4-7 ПДК, в свекле - 3-8 ПДК, Pb - в картофеле - 12-15 ПДК, в моркови - 12 ПДК, в свекле - 11-14 ПДК.

Проведенный расчет индивидуального и популяционного канцерогенного риска показал, что загрязнение воды, почвы и растений БП, Cd, Pb является источником канцерогенного риска низкого (10-4) и среднего (10-3) уровней. На первом месте по значению канцерогенного риска находится загрязнение овощей. Веществами, создающими максимальный канцерогенный риск, являются свинец и кадмий.